

SURAT EDARAN
NOMOR : 821/RSPHS/I-SE/DIR/IX/2025

TENTANG
TANGGUNG JAWAB UNIT PELAYANAN
PADA KELENGKAPAN DOKUMEN KLAIM BPJS KESEHATAN

Berdasarkan **Pedoman Pelayanan Asuransi Center Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 152.2/RSPHS/I-PER/DIR/II/2023**, disampaikan bahwa kelengkapan dokumen klaim RJTL (Rawat Jalan Tingkat Lanjut) dan RITL (Rawat Inap Tingkat Lanjut), baik manual maupun digital, wajib dilengkapi oleh unit terkait sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien JKN/KIS.

Adapun dokumen klaim manual maupun digital yang menjadi tanggung jawab unit pelayanan adalah sebagai berikut:

NO	UNIT	DOKUMEN		PIC
		RAWAT JALAN	RAWAT INAP	
1.	Pendaftaran	1. Surat Kontrol / Rujukan 2. SEP RJ	1. SEP RI	Fina Fitriana Nurhayati, AMd. RMIK
2.	Poli Rawat Jalan	1. Resume Rawat Jalan 2. Lembar Rujuk Internal atau Konsul Internal 3. Laporan tindakan apabila ada (Laporan Phaco, Laporan ESWL, Protokol Injeksi Intraartikular, Laporan Curretage, dll) 4. Rehab Medik (Pengkajian Awal Rehab Medik, Protokol terapi Rehab medik, CPPT/ Evaluasi, form rujuk internal) 5. SITB	1. SPRI	Bagas Suryo Purwono, AMd. Kep
3.	IGD	1. Triage 2. Pengkajian Medis Awal IGD 3. Pengkajian Awal Keperawatan 4. Form rujukan 5. Form surat kematian 6. Form false emergency	1. Triage 2. Pengkajian Awal IGD 3. Pengkajian Keperawatan IGD 4. SPRI 5. Hasil Pemeriksaan Penunjang dari luar 6. Lembar perujuk (untuk bayi mohon di tulis apgar scor dengan lengkap) 7. Form rujukan 8. Form SBAR 9. Form transfer antar unit	1. Seluruh dokter IGD 2. Aini Nur Rohmah, AMd. Kep



			10. Form surat kematian 11. Form dehidrasi 12. Form observasi 13. Form PSI	
4.	Rawat Inap		1. Ringkasan Pulang 2. Pengkajian Awal DPJP 3. Pengkajian Rehab Medik (jika ada) 4. Lembar Konsultasi 5. CPPT (apabila ada informasi tindakan yang dilakukan (pungsi, efusi, punksi acites, ventilator) 6. Lembar Observasi (ICU, PICU, NICU) 7. SITB 8. Form observasi 9. Form rujuk 10. Form surat kematian	1. Siti Maysaroh, AMd. Kep 2. Devi Apriliyanti, AMd. Kep 3. Nila Martiyasani, AMd. Kep 4. Ns. Sinta Olivia Rahayu, S. Kep 5. Debi Firmanasia, AMd. Kep 6. Ns. Ayu Mayang Priningtiyas, S. Kep
5.	IKO		1. Laporan Operasi 2. Laporan Anastesi	Rizky Dwi Ramadhani, AMd. Kep
6.	Maternitas		1. Laporan Tindakan 2. Pengkajian Awal Kebidanan 3. Data Partus 4. Observasi Inpartu 5. Partograf 6. NST 7. Identifikasi Bayi Baru Lahir 8. Status Bayi 9. SHK 10. Lembar transfer (untuk bayi) 11. Form rujuk 12. Form surat kematian	Ninis Indrawati, S.Tr. Keb.
7.	Hemodialisa	1. Pengkajian awal DPJP 2. Lembar observasi HD 3. Laporan Tindakan (jika ada)	1. Ringkasan Pulang 2. Pengkajian Awal DPJP 3. CPPT 4. Lembar observasi HD 5. Laporan Tindakan (jika ada)	Ns. Allamul Angga Gilang N. R., S. Kep
8.	Laboratorium	1. Hasil pemeriksaan laboratorium (pemeriksaan Internal dan Eksternal ex. PA)	1. Hasil pemeriksaan laboratorium (pemeriksaan	Elza Safarina Ulfa, AMd. AK



			Internal dan Eksternal ex. PA) 2. Lembar tranfusi Darah	
9.	Radiologi	Hasil pemeriksaan radiologi internal dan eksternal	Hasil pemeriksaan radiologi dan eksternal	
10.	Kasir	Kwitansi dan rincian tagihan RJ	Kwitansi dan rincian tagihan RI	1. Rina Mailing Tyas, SE 2. Mega Agustustinin g, S. Sos
11.	DPJP	- Memastikan diagnosis telah tegak secara klinis pada anamnesa pemeriksaan fisik penunjang dan tatalaksana pada saat visite - memastikan kelengkapan dan kejelasan laporan tindakan - memastikan resume medis telah di isi secara lengkap dan jelas - Berkomunikasi dengan DPJP penunjang jika hasil pemeriksaan penunjang dengan diagnosis klinis berbeda	- Memastikan diagnosis telah tegak secara klinis pada anamnesa pemeriksaan fisik penunjang dan tatalaksana pada saat visite - Memastikan kelengkapan dan kejelasan laporan operasi untuk DPJP bedah - Memastikan ringkasan pulang / resume medis telah di isi secara lengkap dan jelas - Berkomunikasi dengan DPJP penunjang jika hasil pemeriksaan penunjang dengan diagnosis klinis berbeda	Seluruh DPJP
12.	Dokter Ruangan		- Memastikan diagnosis yang di tetapkan oleh DPJP lengkap, jelas secara anamnesa pemeriksaan fisik, penunjang dan tata laksana - Mengkomunikasikan ketidaklengkapan dan ketidakjelasan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis dan tatalaksana DPJP	

			3. Mereview ketidaklengkapan dan ketidakjelasan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis dan tatalaksana yang telah di perbaiki oleh DPJP 4. Mengembalikan indikasi rawat inap di triage dan pengkajian awal IGD ke dokter IGD apabila tidak sesuai 5. Mereview ketidaklengkapan dan ketidakjelasan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis dan tatalaksana yang telah diperbaiki oleh dokter IGD 6. Komunikasi dengan pihak kepala asuransi 7. Memonitoring kontrol biaya pelayanan kesehatan	
--	--	--	--	--

1. Dokumen Rawat Inap beserta ERM **WAJIB** lengkap saat disetorkan ke Rekam Medis dan maksimal H+1 pasien KRS.
2. Hasil PA wajib dilakukan Follow up oleh Laboratorium dengan rentang waktu minimal 5 hari setelah pengiriman sampel dan maksimal 7 hari

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 September 2025
Plt Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep